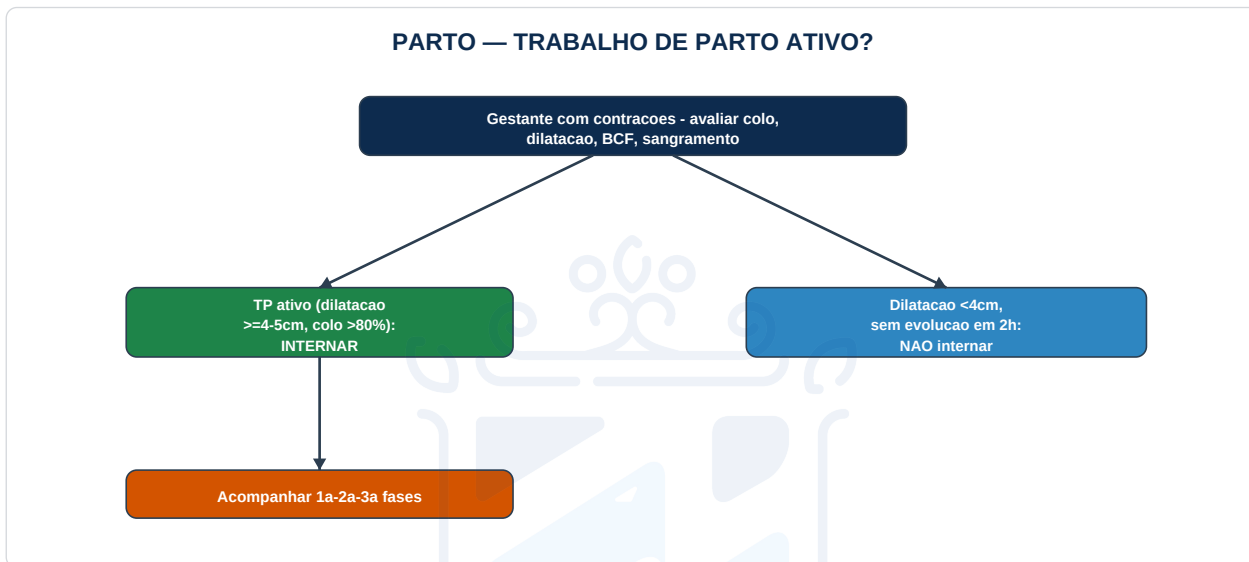


PARTO NORMAL — FASES E ASSISTÊNCIA

FLUXOGRAMA — DECISÃO DE INTERNAÇÃO



INTERNAÇÃO x NÃO INTERNAÇÃO

Internar (TP ativo)	Não internar
Contrações regulares e de intensidade suficiente	Dilatação < 4 cm
Esvaecimento do colo > 80%	Sem mudança de contrações/dilatação em 2h
Dilatação >= 4-5 cm ou em evolução	Membranas íntegras
Trabalho de parto ativo	Cardiotocografia tranquilizadora

EXAME FÍSICO NA ADMISSÃO

AVALIAR

- Sangramento vaginal — descartar placenta prévia, DPP, rotura de seio marginal, rotura de vasa prévia (NÃO fazer toque antes de excluir placenta prévia)
- Dilatação cervical e esvaecimento
- Estática fetal: ponto de referência nas espinhas ciáticas (plano 0 de DeLee)
- Sinais vitais maternos + FC fetal; manobra de Leopold (posição fetal)
- Laboratório: tipagem materna, triagem para HIV, hepatite B e sífilis

CONTRAINDICAÇÕES AO PARTO NORMAL

ATENÇÃO

- Placenta prévia (contra-indicação absoluta)
- Apresentação pélvica (contra-indicação RELATIVA)
- Rotura uterina prévia
- Sangramento vaginal sem causa esclarecida = não tocar até excluir placenta prévia (USG)
- Cardiotocografia não tranquilizadora -> reavaliar via de parto

FASES DO TRABALHO DE PARTO

Fase	Definição	Assistência
1a fase	Início do TP até dilatação total (fase ativa = dilatação acelerada)	Toque a cada 2-3h; FC fetal a cada 30 min; não fazer esforço expulsivo antes da dilatação total; amniotomia opcional na fase ativa (evitar se HIV/hepatite)
2a fase	Dilatação total até o nascimento (30 min-1h)	FC fetal a cada 15 min/após contração; massagem perineal com compressas quentes; NÃO fazer episiotomia de rotina
3a fase (dequitação)	Nascimento até saída da placenta (até 30 min)	Manejo ATIVO (uterotônico + tração controlada + clampeamento) reduz HPP; examinar placenta/membranas

MANEJO ATIVO x FISIOLÓGICO DO 3º PERÍODO

DEQUITAÇÃO

- Manejo ATIVO (recomendado): uterotônico de rotina (ocitocina 10 UI IM), clampeamento e tração controlada do cordão -> reduz hemorragia pós-parto
- Manejo fisiológico: sem uterotônico de rotina, clampeamento após cessar a pulsação, expulsão por esforço materno
- Clareamento OPORTUNO do cordão (1-3 min) beneficia o RN
- SEMPRE examinar a placenta e as membranas (integridade — retenção causa HPP)
- Episiotomia: NÃO de rotina (apenas seletiva)

CUIDADOS COM A MULHER APÓS O PARTO

PÓS-PARTO IMEDIATO

- ☐ Avaliar condição clínica geral e sinais vitais
- ☐ Avaliar a perda sanguínea (vigiar hemorragia pós-parto)
- ☐ Garantir micção bem-sucedida
- ☐ Dieta livre e livre atividade materna; controle de dor
- ☐ Avaliar a regressão (involução) uterina e o contato pele a pele/amamentação

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Gestante ____ semanas, em trabalho de parto ____ (latente/ativo); dilatação ____ cm; BCF ____.
- Sangramento: ____ (placenta prévia excluída?); apresentação ____; CTG ____.
- Sorologias (HIV/HBV/sífilis): ____; intercorrências: ____.
- Solicito transferência para maternidade (parto iminente/intercorrência) — informar dilatação e BCF.

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Gestante a termo com contrações regulares, colo esvaecido > 80% e dilatação de 5 cm em evolução. Conduta?

- A) Não internar e reavaliar em casa
- B) Internar — trabalho de parto ativo
- C) Cesárea de urgência
- D) Indução com ocitocina
- E) Alta com analgésico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Gestante com sangramento vaginal na admissão. Qual conduta é correta ANTES do toque vaginal?

- A) Realizar o toque imediatamente
- B) Excluir placenta prévia (USG) antes de tocar
- C) Iniciar ocitocina
- D) Romper as membranas
- E) Administrar misoprostol

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre a episiotomia no parto normal, é correto:

- A) Deve ser feita de rotina em todas as primíparas
- B) NÃO deve ser realizada de rotina (apenas seletiva)
- C) É obrigatória na 2a fase
- D) Substitui a massagem perineal
- E) Reduz a hemorragia pós-parto

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual a vantagem do manejo ATIVO do terceiro período do parto?

- A) Acelera a dilatação
- B) Reduz a hemorragia pós-parto (uterotônico + tração controlada + clampeamento)
- C) Evita a episiotomia
- D) Reduz a dor das contrações
- E) Aumenta o peso do recém-nascido

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é uma contraindicação ABSOLUTA ao parto normal?

- A) Apresentação pélvica
- B) Placenta prévia
- C) Diabetes gestacional controlada
- D) Idade materna avançada
- E) Cesárea prévia única

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Contrações regulares + colo esvaecido > 80% + dilatação $\geq$ 4-5 cm em evolução caracterizam trabalho de parto ativo, indicando internação. Dilatação < 4 cm sem evolução em 2h não interna.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Diante de sangramento vaginal, deve-se excluir placenta prévia (por USG) ANTES do toque vaginal, pois o toque pode desencadear hemorragia maciça na placenta prévia.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A episiotomia NÃO deve ser de rotina; seu uso é seletivo. Massagem perineal com compressas quentes é preferida para proteção do períneo na 2a fase.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O manejo ativo do 3o período (uterotônico de rotina, tração controlada do cordão e clampeamento) reduz a incidência de hemorragia pós-parto, principal causa de morte materna evitável.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A placenta prévia é contraindicação absoluta ao parto normal. A apresentação pélvica é contraindicação relativa; cesárea prévia única e DG controlada não contraindicam por si só.

SM24
Suporte ao Plantão Médico